Carte 01

Quelles dimensions composent la définition OMS de la santé ?

Carte 02

Que fait principalement l'OMS ?

Carte 03

Quels sont les trois domaines de One Health ?

Carte 04

Pourquoi associer les vétérinaires à la santé publique ?

Carte 05

Comment articuler politiques internationales et interventions locales en santé globale ?

Carte 06

Quand s'appliquent les OMD ?

Carte 02

Coordonne la santé internationale et émet des recommandations.

Carte 01

Bien-être physique, mental et social.

Carte 04

Pour surveiller et prévenir les risques aux interfaces humains–animaux.

Carte 03

Santé humaine, santé animale et environnement.

Carte 06

De 2000 à 2015 ; ils comportent 8 objectifs.

Carte 05

Définir les priorités collectives, puis adapter les interventions aux communautés et au contexte local.

Carte 07

Que faut-il préciser pour interpréter un seuil de pauvreté monétaire ?

Carte 08

Quel est le sujet de l'ODD 3 ?

Carte 09

Pourquoi un taux de pauvreté en baisse peut-il masquer des effectifs élevés ?

Carte 10

Combien d'objectifs composent les ODD et pour quelle période ?

Carte 11

À population et méthode identiques, que change le relèvement d'un seuil de pauvreté ?

Carte 12

Une proportion peut-elle baisser alors que l'effectif correspondant augmente ?

Carte 08

La bonne santé et le bien-être à tout âge.

Carte 07

La devise, le montant par personne et par jour, le millésime, la méthode et le territoire.

Carte 10

Dix-sept objectifs pour la période 2015–2030.

Carte 09

L'effectif dépend aussi de la taille totale de la population.

Carte 12

Oui. Par exemple, 10 % de 1 million font 100 000 personnes ; 8 % de 2 millions font 160 000 personnes.

Carte 11

La population située sous le seuil ne peut pas diminuer ; elle peut rester identique ou augmenter.

Carte 13

À quoi servent les indicateurs de santé ?

Carte 14

Que vérifier avant de comparer deux taux ?

Carte 15

Quelle différence entre effectif et taux ?

Carte 16

Pourquoi une estimation statistique est-elle incertaine ?

Carte 17

Quel est le premier réflexe devant un chiffre en santé publique ?

Carte 18

Pourquoi vérifier la qualité du recueil avant de comparer des indicateurs ?

Carte 14

Numérateur, dénominateur, année, territoire et structure d’âge.

Carte 13

Décrire, surveiller, comparer et évaluer la santé des populations.

Carte 16

Elle dépend des données disponibles et des hypothèses du modèle.

Carte 15

L’effectif est un nombre ; un taux rapporte des événements à une population ou à un temps-personne de référence, selon l’indicateur.

Carte 18

Un recueil incomplet ou différent peut modifier le nombre d’événements comptés et limiter la comparaison.

Carte 17

Vérifier unité, période, population, territoire et source.

Carte 19

Que préciser devant un pourcentage de décès ?

Carte 20

Une population peut-elle croître avec un taux de croissance qui baisse ?

Carte 21

Comment calcule-t-on le solde naturel ?

Carte 22

Que traduit une pyramide des âges à base étroite ?

Carte 23

Formule du taux brut de natalité ?

Carte 24

Pourquoi standardiser la mortalité par âge ?

Carte 20

Oui, tant que le taux reste positif.

Carte 19

La population et le total de référence, la période, le territoire et la définition de la cause.

Carte 22

Des générations récentes moins nombreuses, souvent associées au vieillissement.

Carte 21

Naissances moins décès.

Carte 24

Pour comparer des populations ayant des structures d’âge différentes.

Carte 23

Naissances vivantes / population moyenne × 1 000.

Carte 25

Comment est construite l'espérance de vie de période ?

Carte 26

Comment passer du solde naturel à la variation totale d'une population nationale ?

Carte 27

Comment convertir une proportion annuelle de naissances en taux pour mille ?

Carte 28

Quelle différence entre espérance de vie restante et âge moyen au décès associé ?

Carte 29

Jusqu'à quand un décès peut-il être qualifié de maternel ?

Carte 30

Quel est le dénominateur du RMM ?

Carte 26

Ajouter le solde migratoire au solde naturel.

Carte 25

À partir des taux de mortalité par âge observés à une période donnée.

Carte 28

L’espérance restante est une durée à partir de l’âge atteint ; l’âge associé s’obtient en ajoutant cet âge à la durée.

Carte 27

Diviser les naissances vivantes par la population de référence, puis multiplier par 1 000.

Carte 30

Les naissances vivantes ; ratio pour 100 000.

Carte 29

Pendant la grossesse et jusqu’à 42 jours après sa fin, si la cause est liée.

Carte 31

Quelle est la cible mondiale ODD 3.1 pour 2030 ?

Carte 32

Une moyenne de 712 décès par jour correspond à quel ordre de grandeur par minute ?

Carte 33

Quels jours couvre la période néonatale ?

Carte 34

Différence entre mortalité infantile et mortalité des moins de cinq ans ?

Carte 35

Quelles cibles ODD 3.2 pour les enfants ?

Carte 36

Quelle tendance générale suit la mortalité avant cinq ans ?

Carte 32

Environ 0,49 décès par minute, soit environ un décès toutes les deux minutes.

Carte 31

Moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Carte 34

Avant 1 an pour l'infantile ; avant 5 ans pour la seconde.

Carte 33

De la naissance au 27 e jour inclus (avant 28 jours).

Carte 36

Une baisse mondiale, mais des écarts régionaux persistants.

Carte 35

Au plus 12 décès néonatals et 25 décès avant 5 ans pour 1 000 naissances vivantes.

Carte 37

Comment calculer un RMM pour 100 000 naissances vivantes ?

Carte 38

Quel dénominateur distingue le RMM du taux maternel présenté ?

Carte 39

Un décès à 40 jours de vie est-il néonatal ?

Carte 40

Une amélioration d'un indicateur prouve-t-elle que la cible est atteinte ?

Carte 41

Qu'est-ce que la prévalence ponctuelle ?

Carte 42

Neuf nouveaux cas sur 100 sujets suivis deux ans : incidence cumulée ?

Carte 38

Le RMM utilise les naissances vivantes ; le taux maternel considère les femmes en âge de procréer sur une durée.

Carte 37

Décès maternels divisés par naissances vivantes, multipliés par 100 000.

Carte 40

Non. Il faut comparer la valeur à la cible et considérer le rythme de l'évolution.

Carte 39

Non : il survient après les 27 jours révolus. Il appartient aux décès avant un an et avant cinq ans.

Carte 42

9 % sur deux ans, si le suivi est complet.

Carte 41

La proportion de cas existants dans une population à un instant donné.

Carte 43

Quel dénominateur utiliser pour un taux d'incidence ?

Carte 44

Le taux d'incidence est-il une mesure de contagiosité ?

Carte 45

À quoi correspondent 200 personnes-années dans un suivi de 100 personnes ?

Carte 46

Avec 9 nouveaux cas et 196 personnes-années à risque, quel taux d'incidence calcule-t-on ?

Carte 47

Comment une sortie de suivi intervient-elle dans le temps-personne ?

Carte 48

Une prévalence identique implique-t-elle une incidence identique ?

Carte 44

Non. Il mesure la vitesse de survenue de nouveaux cas.

Carte 43

La somme des temps-personnes réellement observés à risque.

Carte 46

9/196≈0,046 nouveau cas par personne-année, soit environ 4,6 pour 100 personnes-années.

Carte 45

À 100 personnes suivies chacune pendant deux ans, si toutes restent à risque et suivies.

Carte 48

Non. La photographie des cas présents ne suffit pas à reconstituer les nouveaux cas sur une période.

Carte 47

Chaque personne contribue uniquement pendant sa durée observée à risque avant sa sortie.

Carte 49

Quelle différence de dénominateur distingue mortalité et létalité ?

Carte 50

Quelle famille domine les décès dans le monde ?

Carte 51

Quelles sont les quatre grandes catégories de MNT ?

Carte 52

Qu'est-ce que la transition épidémiologique ?

Carte 53

Pourquoi éviter un contraste Nord–Sud trop simpliste ?

Carte 54

Que signifie « double charge » épidémiologique ?

Carte 50

Les maladies non transmissibles.

Carte 49

La mortalité rapporte les décès à la population ; la létalité les rapporte aux personnes atteintes de la maladie.

Carte 52

La modification du poids relatif des maladies, souvent vers les pathologies chroniques.

Carte 51

Maladies cardiovasculaires ; Cancers ; Diabète ; Maladies respiratoires chroniques

Carte 54

La coexistence d'infections et de maladies chroniques dans une population.

Carte 53

Les inégalités existent également au sein de chaque pays.

Carte 55

Pourquoi l'information ne suffit-elle pas toujours à la prévention ?

Carte 56

Le VIH et le sida sont-ils deux virus différents ?

Carte 57

Quel parasite et quel vecteur causent le paludisme ?

Carte 58

Quelle prévention réduit les piqûres en zone de paludisme ?

Carte 59

Une infection tuberculeuse latente est-elle contagieuse ?

Carte 60

Comment se transmet la tuberculose pulmonaire active ?

Carte 56

Non. Le sida est un stade avancé de l'infection par le VIH.

Carte 55

La connaissance d'un moyen de protection ne garantit pas les ressources matérielles nécessaires pour l'utiliser.

Carte 58

Moustiquaires imprégnées, répulsifs et lutte antivectorielle.

Carte 57

Plasmodium ; transmission généralement par une femelle Anopheles infectée.

Carte 60

Par l'air, via les aérosols infectieux.

Carte 59

Non, à la différence de certaines tuberculoses actives.

Carte 61

Quel exemple de maladie infectieuse illustre une émergence dans le panorama étudié ?

Carte 62

Une maladie transmissible exige-t-elle toujours un contact direct entre deux humains ?

Carte 63

Quels facteurs modifiables augmentent le risque cardiovasculaire ?

Carte 64

L'AVC et l'infarctus appartiennent à quel groupe de maladies ?

Carte 65

Pourquoi le nombre de décès peut-il monter quand le taux standardisé baisse ?

Carte 66

Dans le panorama cardiovasculaire, comment distinguer HTA/dyslipidémie et AVC/infarctus ?

Carte 62

Non. Un vecteur peut participer à la transmission.

Carte 61

Ebola.

Carte 64

Aux maladies cardiovasculaires.

Carte 63

HTA, tabagisme, dyslipidémie et diabète notamment.

Carte 66

HTA et dyslipidémie sont abordées comme facteurs de risque ; AVC et infarctus sont des affections ou événements cardiovasculaires.

Carte 65

La population peut croître et vieillir en parallèle.

Carte 67

Que mesure l'incidence d'un cancer ?

Carte 68

Quels cancers font l'objet d'un dépistage organisé en France ?

Carte 69

Sur quoi repose une démarche de dépistage individuel ?

Carte 70

Une variation du taux standardisé d'incidence est-elle la variation du nombre brut de cas ?

Carte 71

Quel élément caractérise un dépistage organisé ?

Carte 72

Un examen motivé par des symptômes relève-t-il du même raisonnement qu'un dépistage asymptomatique ?

Carte 68

Sein, colorectal et col de l'utérus.

Carte 67

Les nouveaux diagnostics pendant une période donnée.

Carte 70

Non. Le taux standardisé et l'effectif brut sont deux indicateurs distincts.

Carte 69

Une évaluation personnalisée du risque, notamment à partir des antécédents.

Carte 72

Non. Il s'agit d'une démarche diagnostique pour expliquer les symptômes.

Carte 71

Une population cible est invitée selon les critères d'un programme.